胎児の栄養素ガイド

7つの栄養素の役割と妊娠期別の推奨量 ｜ 厚労省「日本人の食事摂取基準 2025年版」準拠

栄養素	初期（～13週）	中期（14～27週）	後期（28週～）
たんぱく質	50g/日	55g/日	**75g/日**
鉄	9.0mg/日	16.0mg/日	**16.0mg/日**
葉酸	640μg/日*	480μg/日	480μg/日
DHA（n-3系）	1.6g/日	1.6g/日	**1.6g/日**
カルシウム	650mg/日	650mg/日	650mg/日
ビタミンK	150μg/日	150μg/日	**150μg/日**
ビタミンD	8.5μg/日	8.5μg/日	8.5μg/日

*葉酸の初期は食事240μg＋サプリ400μg。

たんぱく質

胎児の体そのものをつくる主役

筋肉・骨格・皮膚・内臓・血液のすべてがたんぱく質から作られる。後期は1日約30～35gが胎児に移行するため、母体は+25gの付加が必要。

不足リスク: 低出生体重児、発育遅延

食材: 肉・魚・卵・大豆・乳製品

DHA

胎児の脳と目をつくる必須脂肪酸

脳の重量の約10%、網膜の脂肪酸の約50%を構成。体内でほとんど合成できず、母体の食事から胎盤経由で供給される唯一のルート。

不足リスク: 神経発達への影響、早産リスク↑

食材: サバ・イワシ・サンマ・鮭（週2-3回）

鉄

母子の酸素供給を支える生命線

妊娠中は血液量が約40%増加。全期間で約1,000mgの鉄を消費（胎児300mg＋胎盤50mg＋血液500mg＋出血150mg）。妊婦の30～40%が貧血。

不足リスク: 貧血、発育不全、早産

食材: 赤身肉・レバー・あさり・小松菜

葉酸

赤ちゃんの神経管をつくる最初の栄養素

DNA合成と細胞分裂に不可欠。受胎後28日以内の神経管閉鎖に関与。十分な摂取で神経管閉鎖障害のリスクが約70%低減（大規模研究で証明）。

不足リスク: 二分脊椎・無脳症、貧血

食材: ほうれん草・ブロッコリー・枝豆・納豆

カルシウム

胎児の骨と歯の材料

出産までに約30gが胎児に蓄積。妊娠中は吸収率が約2倍に上昇するため付加量は設定なし。ただし日本人女性は元々の摂取量が不足気味。

不足リスク: 母体の骨密度低下、妊娠高血圧

食材: 牛乳・ヨーグルト・小魚・豆腐

ビタミンK

出産時の出血と新生児を守る

血液凝固に必須。胎盤を通過しにくいため新生児はK欠乏になりやすい。後期に十分摂取することでへその緒経由の供給量を増やす。

不足リスク: 異常出血、新生児出血症

食材: 納豆・ほうれん草・小松菜・ブロッコリー

ビタミンD

カルシウム吸収と免疫の調整役

カルシウムの腸管吸収を促進し骨形成を間接的に支援。不足は妊娠糖尿病・妊娠高血圧・早産リスクと関連。日本人女性の多くが不足。日光浴15分/日も有効。

不足リスク: 胎児のくる病、母体の骨粗鬆症

食材: 鮭・サンマ・しらす・きくらげ・卵黄 ＋ 日光浴

出典: 厚労省「日本人の食事摂取基準 2025年版」/ 厚労省「妊産婦のための食生活指針 令和3年改定」/ 日本産科婦人科学会 診療ガイドライン 2023